

Evaluación inicial y control prenatal

1. Introducción y relevancia clínica

El **control prenatal** es el conjunto de acciones médicas, educativas y sociales destinadas a **asegurar la salud de la madre y del hijo**, mediante la **detección precoz de factores de riesgo**, la **prevención de complicaciones** y la **educación de la gestante**.

Su relevancia clínica radica en que:

- Reduce significativamente la **mortalidad materna y perinatal**.
- Permite la **detección oportuna de patologías** frecuentes (preeclampsia, diabetes, infecciones, RCIU).
- Garantiza intervenciones preventivas costo-efectivas (**ácido fólico, hierro, vacunas, PTGO, tamizajes infecciosos**).

En Chile, el control prenatal está amparado por las **Normas de Atención Integral a la Mujer** y la **Guía Perinatal MINSAL 2023**, además de formar parte de las **Garantías Explícitas en Salud (GES)**: *“Embarazo, parto y puerperio”*.

El estándar nacional exige **captación antes de la semana 14** y un mínimo de **6 controles prenatales** correctamente realizados.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El embarazo normal implica adaptaciones sistémicas que cambian los valores de referencia clínicos y de laboratorio (ver tema anterior).

El control prenatal busca:

1. **Acompañar dichas adaptaciones**, identificando cuándo sobrepasan lo fisiológico.
2. **Detección temprana de riesgo**: hipertensión, diabetes, RCIU, infecciones.
3. **Educación continua** sobre nutrición, actividad física, signos de alarma, lactancia y planificación familiar.

El control prenatal efectivo **no sólo mide y examina**, sino que **enseña y vincula a la paciente con el sistema sanitario**, permitiendo intervenciones preventivas en tiempo real.

3. Clínica: primera consulta prenatal

La **primera consulta** (idealmente <14 semanas) es la más importante del control prenatal.

Debe ser **integral, prolongada y estructurada**.

Contenidos principales:

a.

Anamnesis completa

- **Identificación:** edad, paridad, ocupación, domicilio, cobertura de salud.
- **Antecedentes gineco-obstétricos:** FUR, FPP, ciclos, abortos, partos previos, cesáreas, peso RN previos, complicaciones.
- **Antecedentes médicos y quirúrgicos:** HTA, DM, cardiopatías, epilepsia, cirugías uterinas.
- **Antecedentes familiares:** preeclampsia, RCIU, diabetes, malformaciones, gemelaridad.
- **Hábitos y factores sociales:** tabaquismo, alcohol, drogas, violencia, apoyo social.

b.

Examen físico completo

- **Signos vitales:** PA (sentada, reposo ≥ 10 min), pulso, T°, FR, IMC.
- **Talla y peso inicial:** permite calcular **IMC pregestacional** → clasifica riesgo nutricional.
- **Examen mamario:** pezones, secreción, masa.
- **Examen obstétrico inicial:** palpación uterina (a partir de 12 s), altura uterina, tacto vaginal si es necesario (descartar cuello corto, tumoraciones).
- **Examen general:** tiroides, corazón, pulmones, abdomen, extremidades, piel.

□ **Presión arterial $\geq 140/90$ mmHg** antes de 20 semanas sugiere **HTA crónica** (no gestacional).

4. Exámenes complementarios del primer control

(según Guía Perinatal MINSAL 2023 y normativa GES)

Tipo de examen	Objetivo / Interpretación
Hemograma completo	Diagnóstico de anemia (Hb <11 g/dL) y valoración inicial del estado nutricional.
Grupo sanguíneo y Rh	Identificar incompatibilidad Rh.
Test de Coombs indirecto (si Rh-)	Detectar sensibilización. Si negativo → repetir en semanas 28 y 36.
Orina completa y urocultivo	Detección de bacteriuria asintomática (tratamiento obligatorio).
Glicemia en ayunas	Descartar diabetes preexistente (≥ 126 mg/dL = DM).
VDRL o RPR	Tamizaje de sífilis (repetir en 32 s).
VIH	Consentimiento informado; repetir en T3 según riesgo.
Hepatitis B (HBsAg)	Si positiva → derivar a infectología.
Toxoplasmosis (IgG/IgM)	Según disponibilidad; si seronegativa → reforzar prevención.
Examen dental y PAP	Si corresponde; prevención integral.

Ecografía obstétrica temprana

Confirmar embarazo, número de embriones, vitalidad, y datar edad gestacional.

- ☐ El **urocultivo positivo** debe tratarse incluso sin síntomas, por el alto riesgo de **pielonefritis y parto prematuro**.

5. Evaluación del riesgo obstétrico

Se realiza en **cada control** y se actualiza dinámicamente.

a.

Riesgo alto (criterios principales)

- Edad <18 o >35 años.
- Paridad ≥ 5 .
- Antecedente de preeclampsia, eclampsia, parto prematuro o RCIU.
- Enfermedades crónicas: HTA, DM, nefropatía, cardiopatía, epilepsia.
- Embarazo múltiple.
- IMC <18 o >30.
- Hemorragia vaginal o amenaza de aborto.
- Sospecha de malformación fetal.
- Condiciones sociales o de salud mental adversas.

Las pacientes de riesgo alto deben controlarse con **mayor frecuencia, en nivel secundario o de referencia**, según protocolo MINSAL.

6. Calendario de controles prenatales

Etapa gestacional	Frecuencia recomendada (MINSAL)
-------------------	---------------------------------

Hasta 28 semanas 1 control cada 4 semanas

28–36 semanas 1 control cada 2 semanas

Desde 36 semanas 1 control semanal

Total mínimo exigido: ≥6 controles bien documentados

Cada control debe incluir:

- Medición de **PA, peso, altura uterina, latidos fetales** (desde 12–14 s), y **evaluación de edemas y síntomas**.
 - Registro en la **Tarjeta de Control Prenatal**.
 - **Refuerzo educativo** en cada visita.
-

7. Exámenes por trimestre

Primer trimestre (0–13 s)

- Exámenes basales (tabla previa).
- Ecografía precoz (ideal 11–13+6 s) para **datación y screening cromosómico** (translucencia nucal).
- Consejería nutricional y suplementación:
 - **Ácido fólico 1 mg/día**.
 - Control IMC y orientación dietaria.

Segundo trimestre (14–27 s)

- **Hemograma de control**: evaluar ferropenia o anemia.

- **Glicemia post carga 75 g (PTGO)** entre 24–28 semanas.
- **Ecografía morfológica** (18–22 s): descartar malformaciones.
- **Coombs indirecto** si Rh negativo.
- **Vacuna influenza y Tdpa** (DPT acelular) entre 28–32 semanas.

Tercer trimestre (28 s–término)

- **Hemograma** (revalorar anemia).
- **VDRL y VIH** (repetición).
- **Ecografía de crecimiento y líquido amniótico** (≈32–34 s).
- **Cultivo para Streptococcus grupo B (EGB)**: 35–37 semanas.
- **Coombs indirecto final** (si corresponde).
- **Planificación del parto y educación sobre signos de alarma.**

8. Intervenciones preventivas esenciales

Intervención	Indicaciones	Momento
Ácido fólico 1 mg/día	Prevención de defectos del tubo neural	Desde preconcepción hasta semana 12
Hierro (30 mg Fe elemental/día)	Prevención anemia ferropénica	Desde semana 16–18
Calcio (500 mg 2 veces/día)	Mujeres con baja ingesta láctea o riesgo de preeclampsia	Desde semana 20
Vacuna influenza	Toda gestante	Desde semana 13

Vacuna Tdpa (DPT acelular)	Prevención coqueluche neonatal	Entre semanas 28–32
---------------------------------------	--------------------------------	---------------------

Suplementación y consejería nutricional	Control IMC y ganancia ponderal adecuada	Todos los trimestres
--	---	----------------------

9. Educación materna y signos de alarma

Durante el control prenatal se debe reforzar:

- **Nutrición balanceada y ganancia ponderal según IMC pregestacional.**
- **Ejercicio moderado** (caminar, natación, yoga prenatal).
- **Evitar tabaco, alcohol y fármacos sin indicación médica.**
- **Signos de alarma:**
 - Cefalea intensa, visión borrosa, fosfenos.
 - Dolor abdominal o contracciones regulares antes de término.
 - Fiebre, disuria, flujo fétido o hemático.
 - Disminución o ausencia de movimientos fetales.
 - Pérdida de líquido vaginal clara o verdosa.
 - Edema brusco o disnea.

☐ Educar en **autoobservación y consulta precoz** ante cualquier síntoma de alarma.

10. Complicaciones del control prenatal inadecuado

Tipo de deficiencia

Riesgo asociado

Captación tardía (>14 s) Diagnóstico tardío de patologías y pérdida de oportunidad de tamizajes.

Menos de 6 controles Mayor mortalidad materna y perinatal.

No repetir exámenes Diagnósticos omitidos (sífilis, VIH, anemia, DMG).

Falta de educación Falta de adherencia, desnutrición o automedicación.

11. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. Captación ideal **<14 semanas** y **≥6 controles** en total.
2. **Exámenes del primer control:** hemograma, grupo/Rh, orina, glicemia, VDRL, VIH, HBsAg, toxoplasmosis.
3. **PTGO (75 g)** se realiza entre **24–28 semanas**.
4. **Eco de 11–13+6 s** = datación y screening cromosómico.
5. **Vacunas:** influenza (≥13 s) y Tdpa (28–32 s).
6. **EGB 35–37 s** para prevenir sepsis neonatal.
7. Cada control incluye **PA, peso, AU, LCF y educación**.



Errores comunes

- No repetir **VDRL/VIH** en T3.

- No aplicar vacuna Tdpa en T3.
 - Omitir Coombs indirecto en Rh–.
 - Interpretar anemia gestacional como “normal” sin suplementar.
 - No tratar bacteriuria asintomática.
 - No derivar riesgo alto a nivel secundario.
-

12. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El control prenatal debe **iniciarse antes de la semana 14** y tener al menos **6 controles**.
2. El **primer control** incluye anamnesis, examen completo y exámenes basales (hemograma, grupo/Rh, orina, infecciones, glicemia).
3. Se debe **evaluar riesgo obstétrico** y actualizarlo en cada visita.
4. Exámenes claves: **PTGO (24–28 s)**, **eco morfológica (18–22 s)**, **EGB (35–37 s)**.
5. **Vacunas obligatorias:** influenza y Tdpa.
6. **Suplementos esenciales:** ácido fólico (hasta sem 12), hierro (desde sem 16), calcio (si dieta deficiente).
7. La **educación materna y detección de signos de alarma** son parte inseparable del control prenatal.